

7 ☒ ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS 53729147624F3

TIAGO RABELO SPINELLI

IDADE: 46a PESO: 94 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS:

QUEIXAS: Qualidade Sono Ruim; Acorda cansado

MEDICAMENTOS: Duimex; Elipari; Zovok; Acetil (HAS); / Prisma

MÉDICO: Dr. Saulo Nandy (neuro)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: N MALLAMPATI: IAH: 10,4 e/h SPO2: 91%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: N

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

Distúrbio TPPP (vertigem) desde de jan/2024.

PSG com CPAP: 6,0 cmH2O (máx. elevação na PSG) → IAH: 8,0

13/09/2024 Análise de Auto 4 a 7 cmH2O
max UtiP (M)

20/09/24 P= 6.1
IAH= 1.4
m. de uso: 6hs

gua

07/10/24 P= 6.2 ↑ P= 6.6 / APE= ↓ 1
IAH= 0,6 e/h
m. de uso: 6hs.

gua.

18/11/24 P= 6.2 cmH2O
IAH= 0,8
m. de uso: 5hs
fuga=

gua claudia

02/01/25 P= 6.2 cmH2O
IAH= 0,9 e/h
m. de uso: 5h38'
fuga= 7.6 lpm.

gua cláudio

19/02 P = 5.3 em H₂O

25 IAH = 1.0

Fuga = 0,3 efer.

Bem adaptado, porém ficou 7d. de uso. fora

04/04

P = 5,8 cm H₂O

M. de uso: 5h28

25 IAH = 2.4 efer

Fuga = 0,0"

Coloca o APP.

fora avaliação

25/06

P = 6.1 em H₂O

25 IAH = 2.5 efer

M. de uso: 2h40'

Fuga = 0,0.

fora

Descrição do Exame Polissonográfico

1/5

Nome: TIAGO RABELLO SPINELLI			
Sexo: M	Idade: 45 anos	Peso: 92 Kg	Altura: 1,80 m
IMC: 28,4	Data do Exame: 13/06/2023	Exame: 12533_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:15:48 horas e encerrado às 05:40:55 horas, com latência para o sono de 41 minutos e latência para o sono REM de 93 minutos. O tempo total de sono foi de 383,0 minutos, com eficiência do sono de 86,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0,9%	Até 5%
Estágio 2	35,6%	45 - 55%
Estágio 3	57,2%	> 15%
Sono REM	6,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	86,0%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 21,5 minutos ocorreram **35 despertares (índice de 5,5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 51 bpm, a maior de 60 bpm e a menor de 46 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 42 eventos respiratórios, sendo 0 central e 42 obstrutivos. Sendo 8 apnéias, 34 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 6,6/hora**, sendo 1,3 apnéia/hora e 5,3 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 23,8 e a duração máxima de 46,9.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 0,0/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **98%**, sendo a saturação média de **96%**, a maior de **99%** e a mínima de **89%**, permanecendo 0,1 minutos (0,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 36 dessaturações. Índice de dessaturações: 5,6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 0,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 6,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - número de despertares breves dentro da normalidade (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

Nome: TIAGO RABELLO SPINELLI

Data de Nascimento: 22-4-1978

IMC: 29,67

Sexo: Masculino

Data do exame: 18-05-2024

Peso: 94 kg

Altura: 1,78 m

Médico: DR. SAULO NARDY NADER

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia tipo "Split Night"

Exame realizado na noite de 18-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 258,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 62,5 e 114,0 minutos. O tempo total de sono foi de 172,5 min, eficiência de 66,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 71,3%; estágio N3: 19,7%; sono REM: 6,1%. O índice de despertares foi de 3,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 10,4/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 91%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 80 bpm e NREM de 50 - 74 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 10,4/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=91%);
5. latência para o sono aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de um episódio (4) de atividade em EMG de queixo;
8. registro de ronco durante o sono.

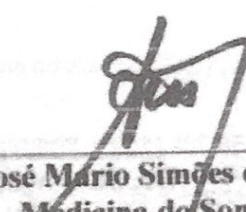
Exame polissonográfico Split-Night evidenciando na primeira parte da noite apneia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: TIAGO RABELLO SPINELLI

Data de Nascimento: 22-4-1978

IMC: 29,67

Sexo: Masculino

Data do exame: 18-05-2024

Peso: 94 kg

Altura: 1,78 m

Médico: DR. SAULO NARDY NADER

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia tipo "Split Night"

Exame realizado na noite de 18-05-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 222,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 22,5 e 85,0 minutos. O tempo total de sono foi de 180,5 min, eficiência de 81,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,3%; estágio N2: 46,3%; estágio N3: 12,7%; sono REM: 37,7%. O índice de despertares foi de 3,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 8,0/hora, sendo 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 20 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 92%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 39 - 77 bpm e NREM de 41 - 72 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM normal;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico Split Night, na segunda parte da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157